EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 91907
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-09-03 08:30:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: GUILLERMO CELSO QUEZADA MENDEZ			RUN	: 7.632.192-2
F.Nac	: 21-09-1955	Edad	: 68 AÑOS, 11 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-08-31	Fecha Egreso	: 2024-09-03 08:30:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I26.9-EMBOLIA PULMONAR SIN MENCIÓN DE CORAZÓN PULMONAR AGUDO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) TEP segmentariolobulo superior e inferior izquierdo
2) NAC lobar derecha
3) Tx raquimedular (paraplejia 2°)
4) HTA
5) Tr depresivo

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente cona ntec descritos, consulta en SU el 30/08 por cuadro de desorientación, agitación, lipotimia, disnea y sensación febril de 2 días evolución. Completó tto ATB por ITU hace 2 días. Ex fisico al ingreso se describe taquicardico, mucosas levemente deshidratadas, abdomen sensible a la palpacion en hemiabdomen izquierdo
Ex de lab al ingreso destaca PCR 44,8; Dimero D 4821, 6; orina leucos 25-50 por campo, GSV pH 7,39; pCO2 50,3; HCO3 30,5

TAC cerebro: Cambios microangiopáticos, sin hemorragia aguda
AngioTAC -> signos de TEP segmentario a nivel de lobulo superior e inferior izquierdo, derrame pleural bialteral leve, neumonia lobar inferior derecha/PESI score 78 pts
Evaluado por Cx por presentar quemadura de 10x 4 cm en cara anterior de EID, sin signos de infeccion local, con esdacelos escasos y superficiales, epitelizando
Se decide ingreso para anticoagulacion a dosis plena y terapia ATB
Durante estancia HDN estable, sin dolor, se inicia terapia ATB de ambio espectro mas broncodilatacion
Examenes de lab 02/09 -> crea 0,8; lactato 0,7; PCR 34,9; uremia 26;

Paciente HDN estable, afebril, sin dolor, con saturaciones fluctuantes entre 90-96% con FiO2 ambiental, sin episodio de nauseas y/o vomitos, con buena tolerancia a aliemtancioN VO, sin sangrado al interrogatorio dirigido
Ex fisico .-> Vigil, CLOTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs, sin uso de musculatura accesoria

Cardiaco RR2T NAS
PUlmonar MP (+) SRA
Extremidades sin edema, sin signos de TVP
Actualmente en su dia N° 3 hospitalizado, dia N° 3 de ceftriaxona, en condiciones de continuar hospitalziacion via HODOm

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin requeirmiento de O2 suplementario
3) Infeccioso/Respiratorio: Con aprametros inflamatorios bajos, se mantendra terapia ATB establecida para compeltar 7 dias en total
4) Hematologico: Sin inconvenientes tras inicio de dagibatran, se continuara hospitalizacion via HOdom para culminar terapia ATB y rehabilitacion kinesica
5) Cx: Continuar con curaciones en EID dia por medio

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo absoluto semisentado 30°
2. Regimen liviano hiposodico a tolerancia
3. Ceftriaxona 2 gr al dia EV por 4 dias
4. Omeprazol 20 mg al dia VO por 4 dias
5. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hrs VO por 4 dias
6. Dabigatran 150 mg c/12 hrs VO por 30 dias
7. Lamotrigina 100 mg 1-0-2 VO por 4 dias
8. Clonazepam 2 mg VO PM por 4 dias
9. Paroxetina 20 mg al dia VO por 4 dias
10. Pregabalina 75 mg 1-1-2 VO por 4 dias
11. Oxibutinina 5 mg al dia VO por 4 dias
12. Bromuro de ipratropio 4 puff c/6hrs por AC
13. Salmeterol/fluticasona 2 puff c/12 hrs por AC
14. KNT motora una vez al dia
15. Examenes de control 07/09
16. Curaciones EID dia por medio (enfermeria)

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO